

AVC isquêmico · janela e conduta

No AVC isquêmico agudo, a sequência de prova é estabilizar, confirmar tempo de início, excluir hemorragia na TC e decidir reperfusão.

Tempo de início

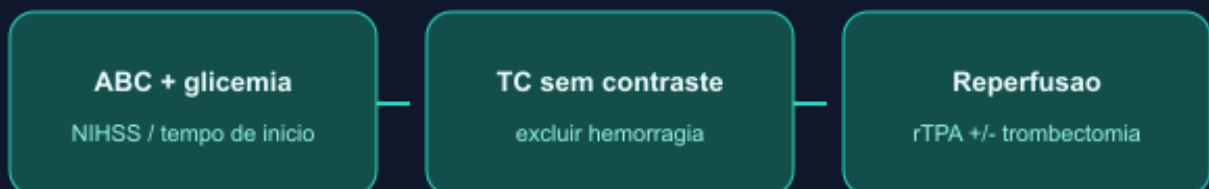
Lembre - Tempo de início

Último momento visto bem. Se acordou com déficit (wake-up stroke), o 'início' clássico é o deitar — critérios de imagem podem expandir indicação em protocolos modernos.

Fluxo de urgência: estabilizar !' imagem !' trombólise/trombectomia conforme janela.

AVC isquemico agudo

Da porta a decisao de reperfusao



Avaliação inicial

- Via aérea, SatO₂, PA, glicemia capilar (corrigir hipo/hiperglicemia extrema)
- NIHSS para gravidade e comunicação com equipe de AVC
- TC de crânio sem contraste o mais cedo possível
- ECG e lab básicos em paralelo — não atrasar imagem

Janelas clássicas de prova

Terapia | Janela típica | Ponto-chave

Trombólise IV (rTPA) | Até 4,5 h | Sem contraindicação; PA controlada

Trombectomia | Até 6 h (selecionados até 24 h) | Oclusão de grande vaso + critérios de imagem

AAS | Se sem trombólise / após janela | Não dar AAS antes se vai trombolisar

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não baixe agressivamente a PA no isquêmico agudo sem trombólise (permissive hypertension). Com rTPA, alvo usual < 185×110 mmHg antes e < 180×105 mmHg nas 24 h.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1